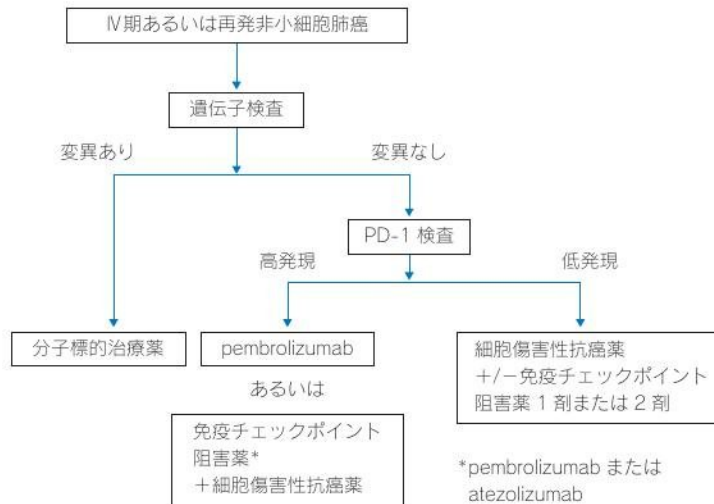




一次治療で使用可能な分子標的治療薬		二次治療以降で使用可能な分子標的治療薬	
EGFR 遺伝子変異	gefitinib	KRAS 遺伝子変異	sotorasib
	erlotinib	HER2 遺伝子変異	trastuzumab deruxtecan
	afatinib	NTRK 融合遺伝子変異	entrectinib
	osimertinib		larotrectinib
	dacomitinib		
ALK 融合遺伝子変異	crizotinib		
	ceritinib		
	alectinib		
	lorlatinib		
	brigatinib		
RET 融合遺伝子変異	semprecatinib		
ROS1 融合遺伝子変異	crizotinib		
	entrectinib		
	repotrectinib		
BRAF 遺伝子変異	dabrafenib + trametinib		
MET 遺伝子変異	tepotinib		
	capmatinib		
	gumalontinib		

図 3 遺伝子異常、PD-L1 発現による肺癌の基本的治療方針

vinorelbine (VNR) の併用投与が行われる。ただし、CDDP と VNR による術後化学療法のエビデンスは海外で樹立されたものであり、投与に際しては十分なリスク評価とインフォームド・コンセントが必要である。また、術後病理病期 II B–III B 期症例で、腫瘍細胞における PD-L1 発現が 50% 以上の症例に対しては、CDDP 併用化学療法後に atezolizumab 単剤療法を追加することが弱く推奨される。一方、PD-L1 発現が 1% 以上 50% 未満の例に対しては、atezolizumab 単剤療法を追加する根拠は明確ではない。さらに、EGFR 遺伝子変異陽性の術後病理病期 II–III B 期症例では、プラチナ製剤併用療法後に osimertinib (3 年間投与) を追加することが弱く推奨される。また、ALK 融合遺伝子陽性の術後病理病期 II–III B 期症例に対しては、

プラチナ製剤併用療法の代わりに alectinib (2 年間投与) による治療が弱く推奨される。

f 進行非小細胞肺癌 (IV 期)

i) 初回治療 (図 3)

『肺癌診療ガイドライン 2025 年版』⁸⁾ によると、非小細胞肺癌においては、治療方針を決定する際に、まず腫瘍におけるドライバー遺伝子変異または転座の有無を検索し、陽性であった場合には、各ドライバー遺伝子に対する分子標的療法を適切なタイミングで検討することが重要であるとされる。一次治療として使用可能な分子標的治療薬として、EGFR 遺伝子変異に対する gefitinib, erlotinib, afatinib, osimertinib, dacomitinib, ALK 融合遺伝子変異に対する crizotinib, ceritinib, alectinib, lorlatinib, brigatinib,